당뇨 목표 숫자와 저혈당 대처

목표는 사람마다 다릅니다. 가끔 튀는 값보다 **평균**을 보고, 저혈당이 의심되면 **느낌만으로 사탕을 먹지 말고 먼저 재 보세요** (잴 수 없으면 당부터). 혈당이 높아도 증상이 없을 수 있으니, 증상이 없어도 검사는 꼭 받으셔야 합니다.

목표 숫자는 사람마다 다릅니다 (My Targets)

일반적인 목표 · GENERAL TARGETS

구분	목표
대부분	당화혈색소 **6.5 미만**
나이가 많거나 저혈당 위험이 크면	저혈당을 피하려고 목표를 **더 높게(느슨하게)** 잡습니다
약 먹는 중	자가혈당 공복 **80~130** · 식후 2시간 **180 미만**

나의 목표 · FOR YOU

나이·건강 상태·저혈당 위험을 보고 **진료실에서 정해 말씀드립니다.** 당화혈색소·공복 혈당·식후 2시간 혈당 목표를 함께 확인하세요.

고령에서는 너무 낮추다 생기는 **저혈당이 더 위험**합니다. 숫자를 무조건 낮추는 게 목표가 아닙니다.

저혈당은 70 미만 — 먼저 재 보세요 (Hypoglycemia)



잴 수 있으면 혈당계가 먼저입니다

이렇게 대처하세요 · WHAT TO DO

증상 **식은땀** **떨림** **두근거림** **어지럼**

1. **먼저 재 보세요.** 느낌만으로 사탕을 먹지 않고, 숫자부터 봅니다. **잴 수 없으면** 정신이 또렷하고 잘 삼킬 수 있을 때 당부터 드세요.
2. **70 미만이면 당 15g** — 포도당 15g 또는 일반 주스 약 120mL(½컵)를 바로 드세요.
3. **15분 뒤 다시 재기** — 여전히 70 미만이면 한 번 더 드세요.
4. **기록해서 알려 주세요** — 저혈당이 반복되면 약 조정을 상의해야 합니다.

흔한 오해 vs 바로 알기 (Common Myths)

자주 듣는 오해 · MYTH	바로 알기 · FACT
"가끔 200이 나오면 약을 바꿔야 한다"	**가끔 튀는 값은 무시하고 평균을 봅니다.** 약은 평균과 당화혈색소로 정합니다.
"5.5까지 낮춰야 한다"	**너무 낮추면 저혈당**이 생깁니다. 목표는 사람마다 다릅니다.
"증상이 없으면 괜찮다"	**혈당이 높아도 증상이 없을 수 있습니다.** 그사이 눈과 콩팥이 망가질 수 있고, 진행하면 되돌리기 어렵습니다. 그래서 일찍 찾아야 합니다.
"메트포르민 먹고 속이 불편하면 약이 안 맞는 것"	초기 불편은 **줄어들 수 있지만**, 심하거나 지속되면 진료실에 알려 주세요.

증상이 없어도 정기 검사 · CHECK-UP

소변(미세알부민)·피검사 — 콩팥 확인, 1년에 한 번 이상
눈 검사(안저) — 망막 확인, 1년에 한 번 이상
당화혈색소 — 3~6개월마다(진료실에서 정합니다)

즉시 119 또는 응급실 · EMERGENCY

의식이 흐리거나 삼키기 어려우면 먹이지 말고 119
당을 먹고 15분 뒤에도 70 미만이 반복될 때
혈당이 계속 매우 높으면서 구토·심한 갈증·처짐

고령자는 건강·기능이 양호하면 당화혈색소 7.0~7.5% 미만, 다중질환·노쇠가 있으면 8.0% 미만을 예로 들며 저혈당·치료 부담에 따라 개별화합니다. (아산28 민세희·백지연)

광교바른내과 · Gwanggyo Barun Internal Medicine
경기 용인 수지구 광교중앙로 298, 4층 · ☎ 031-893-4560
평일 08:30~18:30 · 토요일 08:30~13:30 · 일요일·공휴일 휴진

근거 — 2025 대한당뇨병학회 진료지침 (KDA) · ADA Standards of Care in Diabetes 2026 · ACCORD (NEJM 2008)

함께 보기 — 진료실 설명 슬라이드 「당뇨, 오늘부터 함께 관리합니다」 edu.gwanggyobarun.com/decks/endocrine/diabetes-first-visit/

본 자료는 일반 안내입니다. 개인의 목표 숫자와 약 조정은 나이, 건강 상태, 저혈당 위험에 따라 진료실에서 정합니다.

집에서 다시 보기
QR 대신 입력 → edu.gwanggyobarun.com/handouts/endocrine/diabetes-targets-hypoglycemia/